

Três formas de *tirar isto do papel*

Você me perguntou se faz mais sentido sermos sócios ou você me contratar. Este documento responde as duas coisas, com números, e acrescenta uma terceira possibilidade que acho melhor que as duas.

Para Dr. Miguel De Ari Gomes Agosto de 2026

01

Antes dos números

Vale registrar de onde isto veio, porque muda como eu enxergo a divisão. **O problema foi visto por você.** Saber que o paciente some depois da cirurgia, que a adesão despenca no glaucoma e que ninguém percebe até a consulta seguinte — isso é observação de quem está na sala, não uma ideia que aparece numa conversa qualquer.

E foi você quem puxou a conversa. Sem isso, este projeto não existiria.

Num software para uma especialidade médica, o profissional com domínio clínico e acesso ao mercado costuma ser a metade mais difícil de substituir — não o desenvolvedor.

Digo isso porque é verdade e porque explica os números que vêm depois. Existem muitos programadores capazes de construir este sistema. Existem bem menos oftalmologistas que entendem o problema, conseguem escrever os protocolos e podem apresentá-lo a outros médicos como colega.

02

Onde já chegamos

O trabalho de definição já está feito e documentado. Nada aqui é hipótese solta: cada número desta proposta sai de um desses documentos.

- **Proposta de software** (<https://claude.ai/code/artifact/e4c0ba7f-7134-445e-84a7-ddb296f2f386>) — os quatro módulos, LGPD e sigilo médico, caminho regulatório, arquitetura, roadmap em cinco fases, riscos e decisões abertas.

- **Protótipo navegável** (<https://claude.ai/code/artifact/ff86657a-da29-4bd1-9e90-6e0635ecfe36>) — nove telas clicáveis, com dados fictícios.
- **Custo operacional** (<https://claude.ai/code/artifact/66545bef-0a89-4e3a-a6b9-c6bfc0865685>) — cerca de R\$ 280 por mês para rodar o piloto com 25 pacientes.
- **Estimativa de esforço** (<https://claude.ai/code/artifact/c9a4f255-7e5e-4b92-bc9b-6579ee8e625d>) — o trabalho de engenharia, pacote por pacote.

03

O tamanho do trabalho

Para chegar ao piloto rodando na sua clínica, com pacientes reais sendo acompanhados, são **493 horas** de engenharia, distribuídas em cinco marcos.

MARCO	O QUE FICA PRONTO	HORAS
1 • Descoberta	Protocolos escritos, sinais de alarme definidos, termos de consentimento, especificação e modelo de dados	68
2 • Fundação	Ambientes, publicação, acesso com senha, banco de dados, registro de auditoria, cadastro de paciente	96
3 • Canal	WhatsApp integrado e aprovado pela Meta, modelos de mensagem, motor de protocolo, entrega dos vídeos	104
4 • Inteligência	Triagem das respostas por IA, cálculo de risco, central de risco, consentimento e cancelamento	96
5 • Piloto	Ensaio simulado e quatro semanas acompanhando pacientes reais, com ajustes	94
Total até o piloto		493

Esse escopo deixa de fora, por ora, o prontuário estruturado e o histórico longitudinal — que somam mais 162 horas. A recomendação é adiá-los: eles não são pré-requisito técnico do monitoramento, e o piloto responde antes a pergunta que importa. Se preferir incluí-los desde o início, o total vai a 655 horas.

Sua parte

São cerca de **88 horas** suas, e elas não são acessórias — **sem elas o cronograma para**, por mais que eu trabalhe:

- Cinco ou seis protocolos escritos — o que enviar, em que dia, e o que fazer com cada resposta.
- A lista de sinais de alarme por procedimento, e o que cada um dispara.
- De 8 a 12 vídeos de um a dois minutos, gravados por você. Pode ser no celular.

- Cerca de duas horas por semana durante a construção, conferindo o que sai.

PRECISO SER CLARO

Eu trabalho em horário comercial em outra empresa. Este projeto seria feito em **2 a 3 horas por dia útil e cerca de 4 horas no fim de semana** — entre 14 e 19 horas por semana.

Nesse ritmo, o piloto fica pronto em **7 a 9 meses**. Prefiro dizer isso agora, com todas as letras, do que assumir um prazo que eu não conseguiria cumprir. Qualquer acordo entre nós deve tratar prazo como estimativa, e não como data com multa.

04

Caminho 1 — Prestação de serviço

Você me contrata para construir e depois manter o sistema. Relação de cliente e fornecedor, com preço fechado.

CAMINHO 1 **Você contrata, eu entrego**

R\$ 73.950

493 horas a R\$ 150, pagas nos cinco marcos acima — cerca de R\$ 14.800 por marco

- **Manutenção e evolução após a entrega:** uma base fixa pequena mais horas sob demanda — detalhado logo abaixo.
- **Custo de operação:** cerca de R\$ 280/mês hoje, sempre sem margem. Quem paga depende de quem mantém o sistema no ar — detalhado logo abaixo.
- **Escopo completo:** R\$ 98.250, se quiser incluir prontuário estruturado e histórico desde o início.

Depois da entrega: o que é fixo e o que é sob demanda

Você não deveria pagar todo mês por melhorias que não pediu. Mas há uma parte que não depende de pedido nenhum, e prefiro separar as duas com clareza.

O QUÊ	POR QUE É ASSIM	QUANTO
Manutenção FIXO Monitoramento, correção de falha, atualização de dependências, resposta a incidente	O sistema fica de pé o tempo todo, com pacientes reais dependendo dos alertas. Servidor cai, a Meta rejeita um modelo de mensagem, uma integração muda — isso acontece pedindo ou não pedindo	1.400 por mês, inclui 8 h
Evolução SOB DEMANDA Novos protocolos, novas telas, mudanças de fluxo	Só existe se você pedir. Em mês sem pedido, não há cobrança nenhuma	150 por hora

Para a evolução, sugiro **banco de horas** em vez de cobrança avulsa — você compra um bloco, usa quando precisar, com validade de seis meses:

BLOCO	VALOR	HORA EFETIVA
10 horas	1.500	150
20 horas	2.800	140
40 horas	5.200	130

POR QUE EXISTE UMA BASE FIXA

Sendo transparente: eu tenho entre 14 e 19 horas por semana no total. **A base fixa é o que reserva capacidade para você** — sem ela, um chamado seu entra numa fila junto com tudo o mais, e eu não teria como prometer prazo de resposta.

Num sistema em que um alerta perdido pode significar um paciente não atendido a tempo, acho que essa previsibilidade vale os R\$ 1.400. Se você preferir o modelo totalmente sob demanda, é possível — mas então a resposta passa a ser por ordem de chegada, e isso precisa estar claro para os dois.

A propriedade do sistema

Este é o ponto que mais muda o valor, e prefiro deixá-lo explícito em vez de deixar cada um presumir. **Os três valores abaixo são alternativas ao preço da tabela acima** — quanto mais direitos, maior o preço.

VARIANTE	O QUE SIGNIFICA	VOCÊ PAGA
Cessão total O sistema passa a ser seu	Você se torna o dono. Eu não posso reaproveitar nada em outro lugar, nem oferecer a ninguém	73.950 100%
Licença exclusiva em oftalmologia Seu na sua especialidade	Você usa e pode revender a outras clínicas de oftalmologia; eu mantenho o código e posso aplicá-lo em outra área da medicina	51.765 70%
Licença de uso Seu para usar, meu para evoluir	Você usa na sua clínica em definitivo, sem prazo; eu posso oferecer o sistema a outras clínicas de oftalmologia	36.975 50%

As proporções são propostas, não padrão de mercado — dá para conversar sobre elas. O que não dá é deixar o assunto em aberto: é a fonte mais comum de desentendimento em contrato de software.

SE FOR LICENÇA DE USO

Nessa variante surge uma pergunta justa da sua parte: se você paga metade e eu depois ofereço o mesmo sistema a outras clínicas, o que sobra para você? Três formas de resolver, e qualquer uma me serve:

Janela de exclusividade — você é o único a usar por 12 ou 18 meses antes de eu poder oferecer a terceiros. **Participação nas vendas** — um percentual do que eu faturar com outras clínicas volta para você, até certo limite.

Condição vitalícia — você nunca paga mensalidade acima do valor inicial, mesmo com o produto crescendo.

Uma observação a seu favor: nas variantes de licença, a manutenção passa a ser diluída entre vários clientes. Isso significa que o valor mensal tende a **cair** com o tempo, em vez de subir — o oposto do que acontece na cessão total, em que você banca sozinho toda a evolução.

Quem opera e quem paga a operação

Os cerca de **R\$ 280 por mês** de servidores, mensagens e IA são coisa distinta do desenvolvimento e da manutenção. Quem paga não depende de quem é dono do código — **depende de quem mantém o sistema no ar**.

VARIANTE	QUEM MANTÉM NO AR	QUEM PAGA A OPERAÇÃO
Cessão total	Você, na sua própria conta com os provedores	Você , direto ao provedor. Se preferir que eu opere, isso vira um serviço à parte, cobrado por fora
Licença exclusiva em oftalmologia	A combinar — pode ser você, para os seus clientes, ou eu	Quem operar. Se for eu, entra embutido no que cada clínica paga
Licença de uso	Eu , num sistema único atendendo várias clínicas	Eu , embutido na mensalidade de cada clínica

MINHA PROPOSTA

Nas duas variantes de licença, em que eu opero o sistema: **a operação da sua clínica sai pelo custo, sem margem, em definitivo**. Você nunca paga mais do que o sistema efetivamente consome para atender os seus pacientes.

Isso fica mais barato com o tempo, e não mais caro. Hoje, com 25 pacientes acompanhados, dá cerca de R\$ 11 por paciente por mês; com algumas centenas de pacientes no sistema, a parte fixa se dilui e cai para a faixa de R\$ 6. Você seria o primeiro a se beneficiar disso.

ATENÇÃO AO NÚMERO

Os R\$ 280 são **a conta de 25 pacientes em acompanhamento**, não um valor fixo. Ela cresce com o número de pacientes monitorados — principalmente mensagens e uso de IA — e a maior parte dela hoje é infraestrutura, que sobe em degraus e não linearmente.

O detalhamento está na [calculadora de custo operacional](https://claude.ai/code/artifact/66545bef-0a89-4e3a-a6b9-c6bfc0865685) (<https://claude.ai/code/artifact/66545bef-0a89-4e3a-a6b9-c6bfc0865685>), onde dá para mexer no número de pacientes e ver a conta mudar.

Caminho 2 — Sociedade

Abrimos uma empresa juntos. Você não me paga pelo desenvolvimento: **a participação é a remuneração**. Eu entrego as 493 horas sem receber, e o que levo no lugar do dinheiro é metade da empresa.

50% / 50%

Sem pagamento pelo desenvolvimento; o retorno de ambos vem do resultado da empresa

- **Você banca os custos** — cerca de R\$ 280/mês de operação, mais R\$ 1.500 a 4.300 de custos únicos até o piloto.
- **Esse dinheiro entra como empréstimo à empresa**, não como participação adicional: a empresa devolve com correção a partir da primeira receita, antes de qualquer divisão de lucro.
- **Participação conquistada ao longo de 4 anos**, com carência de 1 ano, para os dois lados. Quem sair antes não leva o todo.
- **Pró-labore de R\$ 1.800/mês para mim**, começando depois da entrega do piloto e só enquanto não houver receita — a mesma regra do Caminho 3. Também entra como empréstimo seu à empresa, e também é recuperável.

POR QUE METADE

Se a conta fosse só de horas, ela penderia para o meu lado — são 493 contra 88.

Mas hora vezes valor é um péssimo medidor do que você traz. A percepção do problema, os protocolos, o primeiro campo de prova e o acesso a outros oftalmologistas não cabem nessa conta, e sem eles não há produto nem mercado.

Cinquenta por cento não é concessão. É o número que reflete o que cada um coloca.

06

Caminho 3 — Modelo misto

É o meio do caminho entre os dois anteriores, e é o que eu recomendo. A ideia é simples: **você paga uma parte do desenvolvimento em dinheiro, e o restante do meu trabalho se converte em participação.**

CAMINHO	VOCÊ PAGA PELO DESENVOLVIMENTO	O RESTANTE DO TRABALHO	SUA PARTI
1 • Prestação	73.950	Não se aplica — está tudo pago	100%
3 • Misto RECOMENDADO	30.000	R\$ 43.950 se convertem em participação	
2 • Sociedade	0	Os R\$ 73.950 inteiros se convertem	

CAMINHO 3 Pagamento parcial e sociedade

R\$ 30.000 + 55% para você

Cerca de 40% do desenvolvimento em dinheiro; o restante converte em participação

- **R\$ 30.000 pelo desenvolvimento**, distribuídos nos cinco marcos — cerca de R\$ 6.000 por marco.
- **Participação de 55% sua e 45% minha**, com a mesma regra de conquista ao longo de 4 anos e carência de 1.
- **Pró-labore de R\$ 1.800/mês para mim**, começando depois da entrega do piloto e só enquanto não houver receita. Durante a construção não há pró-labore — os marcos já cobrem o período.
- **Custos de operação como empréstimo seu à empresa**, recuperáveis antes da divisão de lucro, igual ao Caminho 2.

POR QUE ESTE

Para você: custa bem menos da metade da prestação de serviço, e você fica com a maior parte da empresa. Mais importante que isso: num produto que precisa evoluir por anos, ter um sócio com interesse de longo prazo funciona diferente de ter um fornecedor com contrato mensal.

Para mim: torna sustentável atravessar sete a nove meses de noites e fins de semana. Trabalhar sem nenhuma contrapartida por esse tempo é o principal motivo pelo qual projetos assim são abandonados no meio — e eu prefiro tratar esse risco agora do que descobri-lo depois.

07

Comparativo

O que cada caminho custa a você em três anos, e o que você tem ao fim deles. Os valores assumem cerca de doze meses entre a entrega do piloto e a primeira receita.

	PRESTAÇÃO	SOCIEDADE	MISTO
Desenvolvimento do piloto	73.950	0	30.000
Mensal após a entrega	1.400 fixo, mais evolução sob demanda	1.800 até haver receita	1.800 até haver receita
Melhorias e novas funções	150/h você pede, você paga	incluídas sou sócio, não fornecedor	incluídas sou sócio, não fornecedor
Custos de operação Servidores, mensagens, IA	~280/mês	~280/mês	~280/mês
Desembolso em 3 anos	~135.000 mais o que pedir de evolução	~36.000	~66.000
Quanto disso volta para você Devolução do empréstimo, a partir da primeira receita	nada	~36.000 tudo	~36.000 tudo, menos os R\$ 30.000 do desenvolvimento
Você fica com	100% do sistema	50% da empresa	55% da empresa

UMA PERGUNTA PARA OS DOIS

Se formos por sociedade, há uma questão que precisa de resposta antes da assinatura: **a partir de quantas clínicas pagantes a empresa consegue bancar uma dedicação integral minha?**

Uma empresa cuja engenharia é permanentemente 16 horas por semana tem um teto de crescimento. Não precisamos responder isso hoje, mas precisamos concordar que é uma pergunta legítima — e que, se a resposta for “nunca”, a prestação de serviço passa a ser o desenho mais honesto para os dois.

08

O que precisa estar escrito, em qualquer caminho

Independente do que escolhermos, sugiro que estes pontos fiquem no papel antes de começar. Escrevê-los agora, enquanto está tudo bem, custa uma reunião.

- 1 Propriedade do sistema e da base de dados**, incluindo o que acontece com o acervo anonimizado de casos, que tende a se tornar o ativo mais valioso.
- 2 Compromisso de horas clínicas**. Protocolos, sinais de alarme e vídeos, com prazo — e o que fazer se atrasarem, já que travam todo o restante.

- 3 **Regras de saída.** Se um de nós quiser sair: quem compra a parte de quem, por qual critério, em quanto tempo.
- 4 **Responsabilidade técnica e clínica.** A responsabilidade clínica é sua por lei; a técnica precisa ser definida entre nós.
- 5 **Exclusividade.** Eu posso atender outra clínica de oftalmologia? Você pode contratar outro desenvolvedor? Melhor decidir do que presumir.
- 6 **Uso do nome RetinAI** e de quem fica o registro.

RECOMENDAÇÃO

Seja qual for o caminho, sugiro que **cada um de nós converse com o próprio advogado** antes de assinar — de preferência alguém acostumado a acordo de sócios em tecnologia. Acordo em que só um lado teve orientação é o que mais gera desentendimento depois, e eu não tenho interesse nenhum nisso.

09

Próximo passo

Independente do modelo, o primeiro trabalho concreto é o mesmo: **duas horas juntos para escrever o protocolo de pós-facectomia**. É o insumo que destrava todo o resto, e serve para os dois avaliarem como é trabalhar junto antes de qualquer compromisso maior.

Não há pressa nenhuma para decidir o modelo. Leia com calma, converse com quem achar necessário, e retomamos quando você quiser — a escolha entre os três caminhos não bloqueia essa primeira conversa sobre o protocolo.

Ari Gomes

Produto e engenharia
arimanoel.gomes@betha.com.br

Dr. Miguel

Direção clínica

Proposta de parceria, agosto de 2026. Valores de hora, custos de operação e projeções são estimativas fundamentadas nos documentos citados na seção 02, e não substituem orçamento formal. As estruturas societárias e contratuais aqui descritas precisam de revisão jurídica antes de virarem acordo.